

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA
NS

WALDIR TONELLO

IDADE: 70 PESO: 91 ALTURA: 1,67 PROFISSÃO: Aposentado (Engenheiro)
SINTOMAS: HAS, noturna, Ronco, intolerância a glicose (diurna) (Insulina)
QUEIXAS:
MEDICAMENTOS: Rosiglitazone metformina / Rosartatina / Lucretio met.
APB / Escitalopram / Bencilat Oxidado / dexametazona
MÉDICO: Dra. Eliana Cunha (Omeprazol + hidoclorato de zol)
MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO(A) USA MARCAPASSO: () S (X) N
EXERCÍCIO FÍSICO: caminhada não regular
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: 4 JANTAR: 20-22h
HORA QUE DORME: 23:30h HORA QUE ACORDA: 7:30h
COCHILHO (X) SIM () NÃO 30' DORME ACOMPANHADO (X) SIM () NÃO () EVENTUAL
BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA (X) NÃO
FUMO () SIM () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:
TIPO DE RESPIRAÇÃO: durmo xpto (E) BANHEIRO: 2-3 X
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: 94cm CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:
OVERLAP: não MALLAMPATI: IAHL: 80% (2024) SPO2: 88%
PATOLOGIAS ASSOCIADAS: HPB / Arritmia / Gostoso / artrose quadril
CIRURGIAS: (N) NASAL (S) AMIGDALECTOMIA 3 dentes
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: IMC:
COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (S) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA
(S) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS

11/09/24 Análise
18/09/24 P=5-10 cmH₂O / ↓ P=5-8 cmH₂O
IAH=4,3 e/h
m de uso: 8h Bem adaptado Ainda acorda algumas vezes durante a noite
fuga: 2,1/m
Natacha
02/10/24 P=7,3 cmH₂O / fixo P=7,4 cmH₂O
IAH=4,2 e/h Bem adaptado
m de uso: 6h Natacha
fuga: 1,8 l/m
Trocas apneias pl Resmed
18/10 P=7,4 cmH₂O
24 IAH=3,3 e/h
m de uso: 6h 14' Jua
10/01 P=7,4 cmH₂O
25 IAH=1,6
m de uso: 7h 31' Jua claudia
Bem adapt.

01/11/24 $P = 7,4 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 2,5 \text{ e/h}$
mde uso: 7h53'
fuga: 0,0

Bem adaptado
equinox
Natacha

15/04/25 $P = 7,4 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 3,2 \text{ e/h}$
mde uso: 7h17'
fuga: 7 l/m

Natacha

29/07/25 $P = 7,4 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 1,0 \text{ e/h}$
mde uso: 7h55 min
fuga: 10 l/min

quanto higienizado. silis.

Nome: WALDIR TONELLO
Data de Nascimento: 3-10-1953
IMC: 32,99
Sexo: Masculino
Data do exame: 01-02-2021

Peso: 92 kg
Altura: 1,67 m
Medico: DRA. ELIANA T. S. CUNHA
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 01-02-2021, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 543,0. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 76,5 e 125,0 minutos. O tempo total de sono foi de 406,0, eficiência de 74,8% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 1,4%; estágio N2: 67,2%; estágio N3: 8,9%; sono REM: 22,5%. O índice de despertares foi de 46,4/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 80,4/hora, sendo elas 123 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 106 hipopnéias. A SpO2 média foi de 95% e mínima de 88%, permanecendo 0,1% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 45 - 59 bpm e NREM de 44 - 65 bpm.

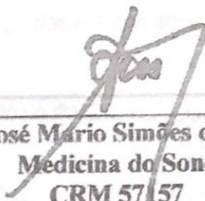
CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (10), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 80,4/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=88%);
5. latências para o sono prolongadas;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco intenso durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau acentuado.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57/57

CON
1. DADOS DA LOCAL
NOME: Faria e
CNPJ: 13
ENDEREC
CEP:

Sleep Study Report

Name of Patient: Valdir Tonello
Name of Referring Doctor: Dra. Rosemeiry Marçal
Date of Study: 16/09/2017

Prezado Valdir Tonello,

Agradecemos por ter se submetido ao estudo do sono de noite inteira com o Watch-PAT. Agora vamos apresentar abaixo os dados obtidos do seu exame.

Seu tempo total de estudo (que é calculado do horário que você ligou o equipamento até você retirá-lo do braço) foi de 8 hrs, 21 min. Mas como estamos avaliando para Apnéia Obstrutiva do Sono estamos interessados no tempo que você ficou dormindo. Seu tempo total de sono foi de 6 hrs, 41 min. Em média, uma pessoa com hábitos de sono normais dorme de 6 a 8 horas por noite.

Observando seus dados do sono podemos obter algumas informações importantes:

Seu Índice de Apnéia/Hipopnéia (abreviado como AHI—apnea/hypopnea index) foi de 35,8. Esse valor é o número médio de eventos de apnéia e hipopnéia por hora de sono durante a noite. Evento de apnéia é um episódio de oclusão total da respiração por mais de 10 segundos, e um evento de hipopnéia é um episódio de oclusão parcial. O valor normal do AHI é de 5 ou menos.

O seu Índice de Distúrbio Respiratório (RDI) foi de 37,9. Esse valor é calculado de uma forma muito similar ao AHI mas adicionando um tipo de evento respiratório chamado RERA que também é contado. O RERA é a abreviação de Respiratory Effort Related Arousal – Despertares Relacionados ao Esforço Respiratório – que é essencialmente um pequeno despertar de poucos segundos em seguida de uma oclusão parcial das vias aéreas. O valor normal do RDI é também de 5 ou menos.

O seu Índice de Desaturação de Oxigênio (ODI) foi de 21,1. O Esse valor é o número médio de vezes que o Oxigênio no seu sangue cai 4% ou mais durante uma hora de sono. Como pode imaginar, quanto mais o Oxigênio cai mais forte o coração tem que trabalhar. O valor normal do ODI é 5 ou menor.

Analisando seu estágio de sono REM (Rapid Eye Movement – movimento rápido dos olhos) verificamos que você esteve nesse estágio 7,6% do seu tempo de sono. O Sono REM é muito importante porque durante esse estágio seu corpo está sendo reabastecido e nutrido. O valor normal para o REM é entre 15 e 30% dependendo de outras condições. Também acredita-se que é durante o estágio REM que sonhamos.

Se precisar de mais esclarecimentos, favor nos contatar.

Atenciosamente,

Printed on: 18/09/2017

Bruno de Andrade Soares
Otorrinolaringologista
CRM 104.874